



# Zwangsstörungen und Zwangsspektrumsstörungen

Ulrich Voderholzer<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup> Schön Klinik Rosenneck, Prien am Chiemsee, Deutschland

<sup>2</sup> Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum, Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Deutschland

<sup>3</sup> Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg, Deutschland

Zwangsstörungen und Zwangsspektrumsstörungen sind immer noch häufig verheimlichte Erkrankungen und weisen verhältnismäßig niedrige Behandlungsraten auf [1]. Aufgrund von Scham und Verheimlichung wird die Störung sogar innerhalb von Behandlungssettings oft nicht diagnostiziert [2], sodass ein gezieltes Nachfragen nach Symptomen einer Zwangsstörung zu einer gründlichen Erstexploration gehören sollte. In der jüngsten, in Deutschland durchgeführten epidemiologischen Studie war die Zwangsstörung die vierthäufigste psychische Störung [1], was möglicherweise den einen oder anderen überrascht haben dürfte.

Erste Symptome von Zwangsstörungen zeigen sich bei Betroffenen meist schon in der Kindheit und Jugend. Der häufigste Manifestationszeitraum der Störung liegt im jungen Erwachsenenalter, d. h. etwa zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr [3]. Ähnlich wie bei Angststörungen weisen viele Patienten chronische Verläufe auf mit vielfältigen Auswirkungen auf die schulische und berufliche Entwicklung, soziale Beziehungen und die Lebensqualität. Psychiatrische Komorbiditäten, wie etwa affektive Störungen und auch Suchterkrankungen, entstehen oft sekundär aufgrund der hohen Belastung durch die Erkrankung selbst. Darüber hinaus sind Zwangssymptome häufig als komorbide Störung z. B. bei Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen oder Patienten mit Schizophrenie vorhanden und stellen eine besondere therapeutische Herausforderung dar.

Besonders kritisch ist, dass die Therapieform mit der größten Effektstärke, die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) mit Exposition und Reaktionsmanagement, im-

mer noch zu selten und vor allem zu wenig intensiv zur Anwendung kommt, obwohl sie in nationalen und internationalen Leitlinien ausdrücklich empfohlen wird [4]. Zudem wird diese Therapiemethode auch bei Befragungen von Betroffenen in Relation zu anderen Therapieformen am besten bewertet [5].

## » Die KVT mit Exposition und Reaktionsmanagement ist die Therapie mit der größten Effektstärke

Im vergangenen und in diesem Jahr gibt es einige erfreuliche Entwicklungen, die mit der Hoffnung verbunden sind, dass sich sowohl die Diagnostik als auch die therapeutische Versorgungssituation in den kommenden Jahren verbessern könnten.

Erstmalig wurde im vergangenen Jahr eine S3-Leitlinie Zwangsstörungen des Kindes- und Jugendalters für den deutschsprachigen Raum veröffentlicht [6] und in diesem Jahr wird eine revidierte Fassung der S3-Leitlinie Zwangsstörungen des Erwachsenenalters erscheinen.

Zudem werden die sog. Zwangsspektrumsstörungen, welche in der bisherigen International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10 (ICD-10) nur unzureichend beschrieben waren, endlich dem Forschungsstand entsprechend im neuen ICD-11 angemessen beschrieben und in einem eigenen Diagnosekapitel „Zwangsstörungen oder verwandte Störungen“ (ICD-11 6B2x; [7]) berücksichtigt werden.

Das vorliegende Themenheft enthält vier Beiträge zu den Zwangsstörungen und Zwangsspektrumsstörungen, in de-



QR-Code scannen & Beitrag online lesen

nen die oben genannten neuen Entwicklungen aufgegriffen und praxisrelevante Themen zu Diagnostik und Therapie der Krankheitsbilder dargestellt werden.

In dem Beitrag von *Michael Zaudig* wird die neue Klassifikation der Zwangsstörungen und der mit Zwang verwandten Störungen im ICD-11 vorgestellt. Bemerkenswert ist dabei, dass die neue Klassifikation einerseits Ähnlichkeiten aufweist mit der Klassifikation der Zwangsspektrumsstörungen im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5), etwa bezüglich des pathologischen Hortens oder der körperdysmorphen Störungen. Andererseits finden sich aber auch klare Unterschiede, etwa bei der hypochondrischen Störung, den Tic-Störungen und der sog. olfaktorischen Referenzstörung, die anders als im DSM-5 in der neuen ICD-11 den Zwangsspektrumsstörungen zugeordnet werden. Die neue Klassifikation entspricht nun vielmehr dem Stand der Forschung und dem aktuellen Stand der klinischen Erfahrung. Es bleibt zu hoffen, dass dadurch auch die Diagnostik und Therapie verbessert und auch mehr Forschung zu diesen Krankheitsbildern stimuliert wird.

### » Bei Zwangsstörungen liegen charakteristische neurobiologische Veränderungen vor

Der Beitrag von *Endres und Mitarbeitern* enthält eine Übersicht zur Neurobiologie der Zwangsstörungen. Die Autoren referieren, dass bei Zwangsstörungen charakteristische und relativ spezifische neurobiologische Veränderungen vorliegen, und sich die Neurobiologie dieser Störung von der Neurobiologie der Angststörungen unterscheidet. Diese Befunde haben mit dazu beigetragen, dass die Zwangsstörungen im DSM-5 nicht mehr bei den Angststörungen, sondern als abgegrenzte eigene Kategorie berücksichtigt werden. In dem Beitrag enthalten ist auch ein Abschnitt über autoimmune Ursachen von Zwangsstörungen, zu denen in den letzten Jahren stärker geforscht wird.

Der Beitrag von *Voderholzer und Autoren* fokussiert ganz auf die revidierte Fassung der S3-Leitlinie Zwangsstörungen und deren Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie. In den zentralen Empfehlungen zur Psychotherapie, Pharmakothera-

pie und Therapieverfahren bei Therapiere-sistenz haben sich keine wesentlichen Veränderungen in Relation zur ersten Fassung der Leitlinie ergeben. Dennoch gibt es einige neue praxisrelevante Empfehlungen z. B. zur Anwendung und Intensität von Psychotherapie, zu E-Mental-Health und anderen Aspekten. Neue wirksame Medikamente oder auch alternative Psychotherapieverfahren mit besserer Wirksamkeit als KVT und Exposition liegen nicht vor und sind auch in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Eines der wichtigsten Ziele der Leitlinie wird daher sein, dass die schon lange evidenzbasierten Therapiemethoden noch viel stärker als bisher in der Praxis ankommen und durch Implementierungsforschung begleitet werden.

Ein vierter Beitrag der Autoren *Schirmbeck und Zink* befasst sich mit der klinisch häufigen Komorbidität von Zwangsstörungen und Psychosen, die oftmals eine besondere Herausforderung für die Therapie darstellt. Auch hier gab es in den vergangenen 10 Jahren praxisrelevante Forschungsergebnisse, zu welchen die Autorengruppe einen wesentlichen Beitrag geleistet hat.

Wir hoffen, dass wir mit dem vorliegenden Themenheft viele für die Praxis nützliche Informationen zu neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der Zwangs- und Zwangsspektrumsstörungen für Sie aufbereitet haben.

Ulrich Voderholzer

#### Korrespondenzadresse

**Prof. Dr. med. Ulrich Voderholzer**

Schön Klinik Roseneck  
Am Roseneck 6, 83209 Prien am Chiemsee,  
Deutschland  
uvoderholzer@schoen-klinik.de

**Interessenkonflikt.** U. Voderholzer gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

#### Literatur

1. Jacobi F, Höfler M, Strehle J, Mack S, Gerschler A, Scholl L, Busch MA, Maske U, Hapke U, Gaebel W, Maier W, Wagner M, Zielasek J, Wittchen HU (2014) Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland und ihr Zusatzmodul Psychische Gesundheit (DEGS1-MH). *Nervenarzt* 85:77–87
2. Wahl K, Kordon A, Kuelz KA, Voderholzer U, Høhagen F, Zurowski B (2010) Obsessive-compulsive

disorder (OCD) is still an unrecognised disorder: a study on the recognition of OCD in psychiatric outpatients. *Eur Psychiatry* 25(7):374–377. <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2009.12.003>

3. Brakoulias V, Starcevic V, Belloch A, Brown C, Ferrao YA, Fontenelle LF, Lochner C, Marazziti D, Matsunaga H, Miguel EC, Reddy YCJ, do Rosario MC, Shavitt RG, Sundar SA, Stein DJ, Torres AR, Viswasam K (2017) Comorbidity, age of onset and suicidality in obsessive-compulsive disorder (OCD): an international collaboration. *Compr Psychiatry* 76:79–86. <https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2017.04.002>
4. Moritz S, Kuelz A, Voderholzer U, Hillebrand T, McKay D, Jelinek L (2018) "Phobie à deux" and other reasons why clinicians do not apply exposure with response prevention in patients with obsessive-compulsive disorder. *Cogn Behav Ther* 48(2):162–176
5. Voderholzer U, Schlegl S, Diedrich A, Külz AK, Thiel N, Hertenstein E, Schwartz C, Rufer M, Herbst N, Nissen C, Hillebrand T, Osen B, Stengler K, Jelinek L, Moritz S (2015) Versorgung Zwangserkrankter mit kognitiver Verhaltenstherapie als Behandlungsmethode erster Wahl. *Verhaltenstherapie* 25:183–190
6. Walitz S, Renner T, Wewetzer C, Wewetzer G, Hollmann K, Döpfner M (2021) Langversion der interdisziplinären evidenz- und konsensbasierten S3-Leitlinie für Diagnostik und Therapie von Zwangsstörungen im Kindes- und Jugendalter AWMF Register Nr. 028-007. <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/028-007.html>. Zugriffen: 18.06.2022
7. World Health Organization (2019) ICD-11: International classification of diseases. <https://icd.who.int/>. Zugriffen: 18.06.2022